Fasi	*Funzioni*	*Nome e Cognome*	*Firma*	*Data*
Redazione	(*)P. il GdL	Mario Mariottini	MARIO MARIOTTINI REGIONE TOSCANA/01386030488 27.07.2023 07:56:27 UTC	
Verifica	Direttore DiPIO	Vianella Agostinelli	VIANELLA AGOSTINELLI Regione Toscana/01386030488 27.07.2023 12:12:57 GMT+00:00	
	Direttore Dipartimento Medicina Generale	Renato Tulino	RENATO FORTUNATO TULINO Regione Toscana/01386030488 27.07.2023 20:38:36 GMT+01:00	
	Direttore UOC Cure Palliative	Concetta Liberatore	LIBERATORE CONCETTA 27.07.2023 12:56:43 UTC	
	Direttore ad interim del Dipartimento del Territorio Fragilità e Dipendenze	Roberto Turillazzi	MARIA GIOVANNA D'AMATO Regione Toscana/01386030488 28.07.2023 07:05:05 GMT+00:00	
	Direttore delle Professioni tecnico sanitarie e della prevenzione	Daniela Cardelli	DANIELA CARDELLI REGIONE TOSCANA/01386030488 27.07.2023 13:50:32 UTC	
	Direttore della Melicina Legale e Responsabilità Sanitaria	Pas~~s~~quale Giuseppe Macrì	PASQUALE MACRI' Regione Toscana/01386030488 28.07.2023 06:13:28 GMT+00:00	
	Direttore A.D. Medicina Trasfusionale	Pietro Pantone	PIETRO PANTONE REGIONE TOSCANA/01386030488 27.07.2023 16:50:57 UTC	
Approvazione	Direttore Sanitario	Simona Dei	SIMONA DEI Regione Toscana/01386030488 28.07.2023 07:28:43 GMT+00:00	
Controllo	Direttore AD Qualità e Sicurezza delle cure	Roberto Monaco	ROBERTO MONACO Regione Toscana/01386030488 28.07.2023 07:22:10 GMT+00:00	

Gruppo di lavoro composto da:

Bertini Loredana Infermiere di famiglia e comunità della zona Casentino
Ricci Erika Infermiere di famiglia e comunità della zona Valtiberina.
Laura Brunelli Direttore UOS Rischio Clinico e sicurezza delle cure area provinciale senese
Loiacono Antonia Responsabile UF Cure Palliative zona senese
Giulio Corsi Responsabile UF Cure Palliative zona aretina
Anna Paola Pecci Responsabile UF Cure Palliative Area Grossetana

Donella Borracelli Responsabile UF Cure palliative Alta Valdelsa
Daniela Cappelletti Responsabile UF Cure palliative Colline dell'Albegna
Sandro Limaj medico specializzando in igiene e medicina preventiva

Luogo e modalità di conservazione: UOC Cure Palliative	Responsabile Concetta Liberatore

La diffusione del presente documento è assicurata mediante pubblicazione nell'intranet aziendale. Essa inoltre verrà distribuita, a cura della struttura emittente, alla seguente lista di strutture organizzative:

1. MMG
2. Centri emotrasfusionali
3. UUFF Cure Palliative
4. Cure Primarie
5. Dipartimento Infermieristico

INDICE

1. PREMESSA ----------4

2. SCOPO ----------5

3. CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI ----------5

4. RIFERIMENTI NORMATIVI ----------6

5. GLOSSARIO E ACRONIMI ----------7

6. MODALITÀ OPERATIVE ----------10

7.SORVEGLIANZA…… 17

8. MONITORAGGIO……..19

9.SWIM LANE …….. 20
10. FMECA……..21
11.ALLEGATI…….24

1. PREMESSA

L'ospedalizzazione di pazienti fragili presenta una serie di svantaggi:
- elevato rischio di infezioni nosocomiali,
- accessi ospedalieri inappropriati/evitabili,
- difficoltà di trasferimento dei pazienti dal domicilio alla struttura ospedaliera, che gravano sia sui familiari che sull'organizzazione dell'assistenza territoriale con l'impegno di mezzi attrezzati/ambulanze.

Molti di questi pazienti possono avvantaggiarsi, tra le altre terapie somministrabili al domicilio, della terapia trasfusionale, a condizione che venga garantita la sicurezza terapeutica mediante l'adozione di protocolli operativi standard che definiscano livelli di sicurezza e tracciabilità dell'intero processo equivalenti a quelli adottati in ambito ospedaliero.

Tutte le Strutture Trasfusionali assolvono i compiti istituzionali disciplinati dal DM del 2 Novembre 2015 Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti in relazione alle attività trasfusionali per il raggiungimento e il mantenimento dell'autosufficienza di sangue/emocomponenti/emoderivati e l'innalzamento dei livelli qualitativi nella erogazione delle prestazioni di Medicina Trasfusionale, a supporto dei percorsi assistenziali offerti dal Servizio Sanitario nell'ambito dell'assistenza ai pazienti ematologici ed oncologici, del sistema emergenza/urgenza e dei trapianti.
La terapia trasfusionale in regime ambulatoriale è prevista come prestazione esclusivamente ospedaliera (ossia presso ambulatori ubicati nell'ambito di istituti di ricovero ospedaliero pubblici, privati ~~e~~ accreditati e non accreditati) o in struttura ad essa assimilabili. Di fatto il nomenclatore tariffario regionale non prevede una voce specifica per la trasfusione domiciliare ma si può assimilare alle prestazioni ambulatoriali. L'erogazione della trasfusione di sangue e/o emocomponenti rientra tra le prestazioni erogabili a domicilio quando ricorrono le condizioni sopra dette in base alle seguenti linee guida di indirizzo:
1) art. 6 DPR 20.10.92 nell'ambito di cicli di cura programmati possono essere concessi dall'ospedale eventuali farmaci che l'assistito debba assumere al proprio domicilio, ivi compresi quelli autorizzati per il solo uso ospedaliero.
2) parere n. 54 del Consiglio Sanitario Regionale del 22.09.2012: "a livello specialistico, per interventi di particolare complessità, si ritiene possibile che equipes multi-professionali dedicate, garantiscano la continuità assistenziale, sia nelle strutture residenziali che a domicilio, con la presa in carico del pz e la definizione del Piano Assistenza Individualizzato, anche con la somministrazione di farmaci, classificati ad oggi come farmaci ospedalieri, purchè ciò sia espressamente previsto dal PAI e con modalità definiti da protocolli e Linee Guida basate sulla EBM;
3) il Documento Tecnico della Commissione nazionale Legge n.38/2010, Gruppo di Lavoro Cure Palliative Adulti, inserisce tra le prestazioni erogabili a domicilio anche le emotrasfusioni.
Inoltre l'emotrasfusione domiciliare è un tipo di prestazione prevista dal Ministero della Salute nelle specifiche funzionali del flusso SIAD (Sistema Informativo Assistenza Domiciliare)
Occorre considerare che le trasfusioni di plasma o di piastrine pongono problemi diversi rispetto alla trasfusione di emazie; infatti, mentre la trasfusione di globuli rossi a domicilio può trovare un razionale in alcune condizioni di anemia cronica, anche di grado rilevante, le trasfusioni di plasma o di piastrine sono raccomandate in casi molto particolari, che quasi sempre configurano indicazione all'ospedalizzazione, sia per il quadro patologico che pone l'indicazione alla trasfusione, che per la maggiore possibilità di reazioni avverse di questi emocomponenti.

2. SCOPO

La procedura in oggetto descrive le modalità di esecuzione della terapia trasfusionale in sede territoriale della Usl Toscana SudEst nei diversi setting e nelle sue diverse fasi: richiesta emocomponenti, prelievi ematici, invio alla Struttura Trasfusionale di richiesta e campioni, accettazione di richiesta e campioni presso la Struttura Trasfusionale ed evasione della richiesta, consegna degli emocomponenti compatibili e trasporto degli emocomponenti, preparazione del paziente, esecuzione della trasfusione, sorveglianza del paziente e rilevazione di eventuali reazioni trasfusionali, invio della documentazione relativa alla trasfusione alla Struttura Trasfusionale.
Lo scopo è definire criteri uniformi in ambito aziendale per garantire il rispetto delle norme in materia e la sicurezza dei pazienti che effettuano la trasfusione in ambito territoriale.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Sono candidabili alla terapia trasfusionale territoriale di Emazie Concentrate tutti i pazienti con età maggiore di 18 anni che necessitano di trasfusione di Emazie Concentrate e che presentano almeno una delle seguenti condizioni:
1) non trasportabilità riconducibile ad una condizione clinica /familiare del paziente
2) essere "anziano fragile" (soggetti ultra 65enni affetti da malattie croniche complesse, con presenza di comorbilità, instabilità clinica, che seguono più di una terapia e con ridotta autosufficienza).
3) essere "paziente fragile" (oncologici, immunologicamente non competenti o immunodepressi).

Non sono eleggibili per la trasfusione domiciliare:

- pazienti in cui il regime trasfusionale rivesta i caratteri dell'emergenza trasfusionale (rischio di shock emorragico)
- **pazienti che riportino in anamnesi pregresse reazioni trasfusionali o diagnosi di anemia emolitica autoimmune**

DESTINATARI:

1. Medico Responsabile Terapeutico rappresentato da:
   - Medico di Medicina Generale
   - Medici Specialisti (ematologo, oncologo, palliativista, geriatra)
2. Infermiere di famiglia e di comunità ed Infermiere di RSA
3. Personale sanitario alle dipendenze di associazioni Onlus convenzionate con l'Azienda Sanitaria USL Sud Est
4. Medici delle Strutture Trasfusionali
5. Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico delle Strutture Trasfusionali
6. Vettori autorizzati al trasporto Strutture/Servizi coinvolti e relative responsabilità

Tutte le strutture ospedaliere e territoriali che praticano la terapia trasfusionale sono tenute ad applicare le procedure approvate dalle Strutture Trasfusionale aziendali relative a:

- richiesta emocomponenti
- prelievi dei campioni
- trasporto e consegna di richiesta/campioni/emocomponenti
- presa in carico degli emocomponenti
- somministrazione degli emocomponenti
- sorveglianza del paziente alle reazioni trasfusionali
- predisposizione del materiale e dei farmaci per la gestione di eventuali emergenze
- gestione del Rischio Clinico

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

- DPR 20/10/1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attivazione dei posti di assistenza a ciclo diurno negli ospedali”
- Legge 21 ottobre 2005 n° 219: Nuova disciplina del le attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.
- PA.DS.13: Procedura per la gestione della terapia Trasfusionale.
- Decreto Ministero della Salute 21 dicembre 2007:” Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati”. Gazzetta Ufficiale n. 13, 16 gennaio 2008
- Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 207: “Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusione e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”.
- Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261: “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”. Gazzetta Ufficiale n.19, 23 gennaio 2008
- Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia. “Raccomandazioni SIMTI sul corretto utilizzo degli emocomponenti e dei plasmaderivati” settembre 2008.
- Decreto del Ministero delle Infrastruttre e dei Trasporti del 9 settembre 2008 “Regolamentazione degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma”
- Documento Tecnico della Commissione nazionale Legge n.38/2010: Gruppo di Lavoro Cure Palliative Adulti
- Parere n. 54 del Consiglio Sanitario Regionale del 22/09/2012 sulle “Problematiche nella gestione dei percorsi nell’ambito dei servizi territoriali: i farmaci in fascia H
- Delibera di Giunta regionale 730/2013 “Ulteriori misure in merito alla sicurezza trasfusionale”
- Ministero della Salute. Decreto 2 novembre 2015. Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti. Gazzetta Ufficiale n. 300 - Suppl. Ordinario n.69, 28-12-2015

- Accordo tra il Governo e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano “Schema di tipo convenzione tra le strutture pubbliche provviste dei servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale”, 25 maggio 2017
- Standard SIMTI di Medicina Trasfusionale 3^ Edizione ottobre 2017 (Ediz. SIMTI Società Italiana di immunoematologia e Medicina Trasfusionale)
- "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria", pubblicato in G.U. il 14 giugno 2019
- “Raccomandazione per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità ABO” Raccomandazione Ministero della Salute n. 5 aggiornamento, 08/01/2020
- Catalano L, Piccinini V, Pati I, Masiello F, Marano G, Pupella S, Liumbruno GM Italian Blood System 2019: activity data, haemovigilance and epidemiologicalsurveillance. Volume 1: Roma; Centro Nazionale Sangue; 2020

5. GLOSSARIO E ACRONIMI

ADI: Assistenza Domiciliare Integrata
CoBUS: Comitato per il Buon uso del Sangue
Domicilio: luogo di abitazione della persona o “domicilio differito”
EMC: Emocomponente: componente terapeutico del sangue prodotto dal servizio trasfusionale mediante il frazionamento del sangue intero con mezzi fisici semplici o mediante aferesi.
Fc: Frequenza Cardiaca
Emergenza trasfusionale: situazione in cui le condizioni cliniche del paziente sono tali per cui il differimento della trasfusione può mettere in pericolo la vita del paziente stesso e pertanto non è possibile seguire le normali procedure di selezione delle unità e di compatibilità pretrasfusionale
IFC: Infermiere di famiglia e comunità
IRC: Infermiere residenziale comunitario
MAV: Magazzino Area Vasta
MMG: Medico di Medicina Generale
MS: Medico Specialista
PDF: Pediatra di Famiglia
Pa: Pressione Arteriosa
RP: Responsabile del prelievo
RSA: Residenza Socio – Sanitaria – Assistenziale
SCUDO: SERVIZIO DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI
SIAD: Sistema Informativo Assistenza Domiciliare
ST: Struttura Trasfusionale
SVS: Vettore autorizzato per trasporti di richieste/campioni ematici/emocomponenti
Tc: Temperatura Corporea
Trasfusione: Infusione endovenosa di emocomponenti (concentrati eritrocitari) per uso terapeutico
TSLB: Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedic

Matrice Responsabilità

FASI DEL PROCESSO	MEDICO RESPONSABILE TERAPEUTICO	INFERMIERE DI RIFERIMENTO	VETTORE SVS	TSLB della ST	MEDICO della ST
Presa in carico del paziente	R				
VALUTAZIONE CLINICA	R	I			
ACQUISIZIONE CONSENSO INFORMATO	R				
CONSULENZA IMMUNOEMATOLOGICA					R
COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA	R	I			I
FIRMA DELLA RICHIESTA (campo medico)	R	I			
FIRMA DELLA RICHIESTA (campo infermiere)	I	R			
ESECUZIONE PRELIEVI PER PROVE DI COMPATIBILITA'	C	R			
INVIO ALLA ST DI RICHIESTA E CAMPIONI	I	R		I	I
TRASPORTO EMOCOMPONENTI/RICHIESTE/CAMPIONI	I	I	R	I	I
ACCETTAZIONE RICHIESTA				R	I
VALUTAZIONE APPROPRIATEZZA CLINICA RICHIESTA				I	R
ESECUZIONE PROVE DI COMPATIBILITA' E VALIDAZIONE TECNICA DEI RISULTATI				R	C
VALIDAZIONE PROVE DI COMPATIBILITA' E ASSEGNAZIONE				I	R
CONSEGNA EMOCOMPONENTI E DOCUMENTAZIONE AL VETTORE				R	C
PREDISPOSIZIONE ZAINO EMERGENZA CON INTEGRAZIONE FARMACI PREVISTA	C	R			
CONTROLLI IDENTITA' PRETRASFUSIONALI (MEDICO)	R	C			
CONTROLLI IDENTITA' PRETRASFUSIONALI (INFERMIERE)	C	R			
ISPEZIONE UNITA'	C	R			
PREPARAZIONE DEL PAZIENTE		R			
TRASFUSIONE	R	C			
MONITORAGGIO INFERMIERISTICO IN CORSO DI TRASFUSIONE	I	R			
MONITORAGGIO MEDICO IN CORSO DI TRASFUSIONE	R	I			

INTERVENTI IN CASO DI SOSPETTA REAZIONE TRASFUSIONALE	R	C			I
SEGNALAZIONE EVENTI AVVERSI	R	I			I
INVIO ALLA ST DELLA MODULISTICA RELATIVA ALLA AVVENUTA TRASFUSIONE/UNITA' NON TRASFUSE/A	R	C			

LEGENDA LIVELLO DI RESPONSABILITA'

R = RESPONSABILITA' PRIMARIA SULL'ATTIVITA' NEL SUO COMPLESSO
C = COINVOLTO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
I = INFORMATO CIRCA LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

6. MODALITA' OPERATIVE

1) COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI EMOCOMPONENTE

RESPONSABILITA': MEDICO RESPONSABILE TERAPEUTICO

Il Medico Responsabile Terapeutico (Medico MMG, Medico Specialista) che in seguito a valutazione clinica ritenga che il paziente necessiti di terapia trasfusionale domiciliare:

- **informa il paziente/familiare/caregiver** circa i benefici e i rischi della proposta terapeutica, e consegna al paziente l'informativa sulla trasfusione di emocomponenti
- **acquisisce il consenso informato alla trasfusione** come da fac-simile del Decreto 02/11/2015, allegato VII parte G (Allegato 1), segnalando al paziente la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento e la necessità di contattare un medico di riferimento in caso di comparsa di segni o sintomi inattesi nelle 24 ore successive alla trasfusione.
- **compila in ogni sua parte la richiesta di emocomponenti (EC) per trasfusione domiciliare** (Allegato 2)
- **informa il paziente/familiare/Caregiver** ai fini della programmazione dell'attività;
- **informa telefonicamente il medico della ST**, che fornisce eventuale consulenza immunoematologica del caso

- **L'infermiere (IFeC, IRC**) effettua i prelievi per le prove di compatibilità pre trasfusionale e provvede a far recapitare la richiesta ed i prelievi ematici alla Struttura Trasfusionale di pertinenza tramite vettore SVS, nel più breve tempo possibile.

La richiesta di EC deve essere compilata in due copie secondo la modulistica della Struttura Trasfusionale di riferimento.

Per la redazione della richiesta è possibile utilizzare anche:

- ✓ modulistica per compilazione manuale fornita dalla ST di pertinenza

La richiesta deve essere compilata in modo leggibile in ogni sua parte e deve riportare, come da DM 02/11/2015 Allegato VII, parte B:

- le generalità anagrafiche del paziente (cognome, nome, sesso, data di nascita)
- sede domicilio del paziente/struttura richiedente (domicilio privato, RSA, rete cure palliative domiciliari)
- il tipo e la quantità/volume degli emocomponenti richiesti
- la patologia e il motivo della richiesta in modo che risulti chiara l'indicazione alla trasfusione
- il grado di urgenza
- l'indicazione di data e ora previste per la trasfusione
- i dati di laboratorio essenziali per la valutazione di appropriatezza della richiesta e per la scelta degli emocomponenti da assegnare
- i dati di anamnesi immunoematologica (gravidanze e trasfusioni pregresse)
- la data e l'ora della richiesta
- cognome e nome e la firma del medico richiedente
- cognome, nome e firma di chi ha effettuato il prelievo dei campioni ematici destinati alle indagini pre-trasfusionali.

Anche per il MMG è accettata la richiesta su carta intestata della Struttura Trasfusionale di riferimento, recante tutte le informazioni sopra elencate e previste dalla normativa vigente.

N.B. E' necessario indicare sempre il recapito telefonico del Medico responsabile terapeutico che deve essere rintracciabile per eventuali comunicazioni da parte del Medico della ST necessarie per:

- ➢ l'acquisizione di informazioni clinico/anamnestiche sul paziente
- ➢ la segnalazione di problematiche di natura immunoematologiche evidenziate nel corso dei test pretrasfusionali.

2) ESECUZIONE DEI PRELIEVI PER LE PROVE DI COMPATIBILITA'

RESPONSABILITÀ: INFERMIERE/MEDICO

Il Responsabile del Prelievo (RP), ossia l'esecutore del prelievo (Infermiere o Medico) esegue il prelievo del campione per le prove di compatibilità pretrasfusionale e, quando necessario, il prelievo del campione per il gruppo sanguigno di conferma:

PRELIEVO PER LE PROVE DI COMPATIBILITA'
Deve essere eseguito secondo le seguenti modalità:

 identificare il paziente mediante IDENTIFICAZIONE ATTIVA (richiesta al paziente di declinare attivamente le proprie generalità: nome, cognome e data di nascita)
 compilare e applicare il braccialetto identificativo (richiedibile attraverso il MAV) il cui utilizzo è obbligatorio per tutti i pazienti da sottoporre a terapia trasfusionale (D.M. n° 69 02/11/2015 Allegato VII, parte F, punto 1).
I dati identificativi minimi obbligatori che il braccialetto/stringa devono riportare sono: nome, cognome, data di nascita, sesso.
 verificare i dati riportati sul braccialetto identificativo
 se il paziente è incosciente o non collaborante l'identità deve essere verificata attraverso un valido documento di riconoscimento o un parente o tutore.

Il RP procede quindi all'esecuzione del prelievo, utilizzando 1 provetta sterile in EDTA secondo le indicazioni della Struttura Trasfusionale di riferimento:
IMPORTANTE: Riportare sull'etichetta del campione in modo leggibile:

- cognome e nome del paziente;
- data di nascita;
- sede domicilio del paziente (domicilio privato o RSA);
- data e ora del prelievo.
- Firma del sanitario che ha effettuato il prelievo

Sono ammesse anche etichette adesive generate dal gestionale Argos recanti tutti i dati richiesti, purché vengano applicate sulla provetta al letto del paziente, dopo averlo identificato come sopra descritto.
Dopo il prelievo il **RP verifica la corrispondenza dei dati riportati sul campione con quelli della richiesta trasfusionale**
Firma la richiesta in modo leggibile
Registra l'intervento effettuato sulla Scheda territoriale dell'applicativo in uso o sulla documentazione sanitaria del paziente

N.B: il primo prelievo per l'esecuzione delle prove di compatibilità deve essere eseguito entro e non oltre le 72 h antecedenti la trasfusione. Devono essere prelevati almeno 5 ml, possibilmente utilizzando una vena di grosso calibro e con ago di 21G che non provochi emolisi, evitando vene in cui sia in corso una fleboclisi e comunque prima di iniziare infusione di terapie farmacologiche in infusione continua o di emagel o plasma expander.

PRELIEVO PER GRUPPO SANGUIGNO DI CONFERMA.
Allo scopo di evitare trasfusioni incompatibili, (si ricorda che la reazione emolitica da incompatibilità ABO può essere fatale) in caso di paziente non precedentemente tipizzato per il gruppo sanguigno, prima di procedere alla trasfusione deve essere obbligatoriamente eseguito un controllo del gruppo ABO e del tipo Rh(D) del ricevente su campione di sangue prelevato in momento diverso rispetto al campione utilizzato per la prima determinazione del gruppo sanguigno (D.M. 02/11/2015 Allegato VII, parte C, punto 6.2).

Il Medico responsabile della richiesta trasfusionale, quando si trovi di fronte ad un paziente da poco preso in carico, si accerta, telefonando alla Struttura Trasfusionale di riferimento, che il paziente sia noto oppure non noto. Qualora la Struttura Trasfusionale comunichi che il paziente non è presente nei propri archivi informatici, comunica al RP l'esigenza di effettuare il prelievo per l'esecuzione dell'emogruppo.

Tale campione deve essere prelevato successivamente e non contestualmente al campione allegato alla richiesta trasfusionale. Non è previsto un lasso di tempo minimo intercorrente tra il primo prelievo e il secondo prelievo destinato alla conferma di gruppo, possono essere sufficienti anche pochi minuti, purché l'identificazione del paziente e le modalità di prelievo siano conformi a quanto già indicato per il prelievo per le prove di compatibilità. Il campione per il gruppo sanguigno di conferma può essere inviato alla ST insieme alla richiesta di emocomponenti e al campione per le prove di compatibilità. **In assenza del prelievo per il gruppo sanguigno di conferma non sarà possibile l'assegnazione e la consegna delle unità richieste**.

N.B.: Quando, per le condizioni critiche del paziente non sia possibile effettuare il secondo prelievo per il gruppo sanguigno di conferma, il medico responsabile terapeutico informa immediatamente, prima di inviare la richiesta, il Medico della ST e segnala, motivandola, l'impossibilità di eseguire il prelievo su tutte le copie della richiesta.

3) INVIO e TRASPORTO di richiesta e campioni

RESPONSABILITÀ: INFERMIERE/VETTORE SVS

CONFEZIONAMENTO DI CAMPIONI E RICHIESTA I campioni non devono essere contaminati esternamente e devono essere inseriti in un trans-bag la cui cerniera deve essere accuratamente chiusa. La richiesta di emocomponenti deve essere inserita all'interno della tasca portadocumenti del trans-bag.

TRASPORTO DI RICHIESTA E CAMPIONI Il trasporto di richiesta, campioni e la consegna alla ST di pertinenza, sono effettuati dal vettore SVS che viene attivato dal personale infermieristico. Il personale infermieristico provvede anche a programmare il ritiro degli emocomponenti presso la ST da parte del vettore SVS.
L'attivazione di SVS viene effettuata tramite chiamata telefonica (0586 88 88 88- 800 073 330, fax 0586 83 88 08) con trascrizione della richiesta di attivazione del trasporto su apposita modulistica (Allegato 4).

N.B.: la ricevuta di corretta trasmissione via fax non garantisce la corretta ricezione della stessa da parte di SVS, pertanto l'invio dello stesso deve essere seguito da telefonata al vettore SVS per accertarsi della effettiva presa in carico della/e richiesta/e di trasporto.

4) ACCETTAZIONE RICHIESTA EMC PRESSO LA ST, ESECUZIONE DELLE PROVE DI COMPATIBILITA' PRETRASFUSIONALE, ASSEGNAZIONE EMC

RESPONSABILITÀ: TSLB/MEDICO

Il TSLB della ST, al momento della ricezione della richiesta EC, prima dell'accettazione della richiesta verifica:

- la completezza della compilazione della richiesta
- l'idoneità dei campioni
- la corrispondenza richiesta/campioni, con particolare riferimento ai dati anagrafici del campione
- la presenza dei nomi in chiaro e delle firme di Medico richiedente e del responsabile del prelievo sulla richiesta o la presenza della firma del responsabile del prelievo su ciascun campione
- consulta i dati storici, quando disponibili
- fa visionare al Medico la richiesta per la valutazione dell'appropriatezza.

Inoltre.

- ✓ risolve in collaborazione con il Medico, quando possibile, le eventuali non conformità
- ✓ accetta la richiesta e i relativi esami immunoematologici sul gestionale
- ✓ seleziona, in collaborazione con il Medico, le EC da assegnare
- ✓ esegue i test necessari per la determinazione di gruppo e le prove di compatibilità
- ✓ effettua la validazione tecnica dei risultati

Il Medico della ST:

- valuta l'appropriatezza clinica della richiesta e garantisce al medico richiedente la consulenza specialistica, nei casi in cui si rilevi la necessità di integrare o modificare qualitativamente e/o quantitativamente il trattamento proposto, a fronte delle informazioni cliniche e biologiche riportate sulla richiesta stessa, e/o di informazioni aggiuntive eventualmente acquisite ad integrazione
- fornisce indicazioni al TSLB relative alla selezione degli emocomponenti, quando necessario,
- valida i risultati delle prove di compatibilità pretrasfusionale,
- se necessario, contatta telefonicamente il Medico richiedente per segnalare eventuali problematiche immunoematologiche relative alla tipizzazione del paziente e all'accertamento della compatibilità
- assegna gli emocomponenti

N.B.: le richieste e i campioni che presentano non conformità non risolvibili quali richieste incomplete o non leggibili, richieste accompagnate da campioni di sangue privi dei dati obbligatori per legge, richieste e campioni di sangue con dati discordanti tra loro, non possono essere lavorate dalla ST. Analogamente campioni insufficienti, coagulati, fortemente emolizzati non possono essere processati. Il campione destinato alle prove di compatibilità pretrasfusionale deve essere sufficiente anche per eventuali test aggiuntivi giudicati necessari dal Medico della ST, e deve essere disponibile per ulteriori test di verifica a seguito di eventuali reazioni trasfusionali immediate o ritardate (il campione deve essere conservato, a questo scopo, per 7 giorni dal momento della trasfusione).

5) CONSEGNA DI EMOCOMPONENTI

RESPONSABILITÀ: TSLB

La/le unità da trasfondere vengono consegnate dal TSLB, previa verifica della loro integrità, al vettore SVS. Il servizio SVS è attivato dalla struttura richiedente EC e programmato sulla base di data e ora indicati sulla richiesta di EC e condivisi con la ST. Ad ogni unità di EC è allegata la documentazione prevista dal SGI della ST di pertinenza.
Su ogni unità di emocomponente assegnata è applicata un'etichetta (etichetta di assegnazione) recante i dati anagrafici e gruppo sanguigno del ricevente a cui l'emocomponente è destinato, l'attestazione di compatibilità e i dati identificativi dell'emocomponente stesso. Tale etichetta deve essere rimossa dall'unità e attaccata nell'idoneo spazio della cartella trasfusionale.
È inoltre consegnato il referto di gruppo sanguigno (da conservare insieme alla cartella trasfusionale domiciliare/o di struttura).

N.B.: SVS può consegnare emocomponenti esclusivamente al personale sanitario, che dovrà pertanto essere presente nel luogo e all'orario previsti, indicati sulla richiesta di trasporto emocomponenti inviata al vettore SVS. Dal momento della consegna degli emocomponenti da parte di SVS il personale sanitario è responsabile della presa in carico, della gestione e dell'integrità delle unità.

6) PREPARAZIONE MATERIALE PER LA TRASFUSIONE DOMICILIARE

RESPONSABILITÀ: INFERMIERE

I materiali/farmaci da rendere disponibile durante la trasfusione domiciliare sono quelli previsti dall'allegato 6"Check List ZAINO EMERGENZA.

Il giorno dell'accesso domiciliare per l'effettuazione della trasfusione l'infermiere verificherà la dotazione e provvederà a renderla disponibile presso il domicilio.

7) PREPARAZIONE DEL PAZIENTE PER LA TRASFUSIONE

RESPONSABILITÀ: INFERMIERE

La preparazione del paziente viene effettuata secondo la seguente procedura:

- fare assumere al paziente la posizione più confortevole e idonea alle sue condizioni di salute nel rispetto del decubito obbligato;
- predisporre a letto del paziente il necessario per approntare la trasfusione nel rispetto dell'igiene ambientale,

- non è strettamente necessario il digiuno del paziente salvo diversa indicazione medica; se il paziente dovesse mangiare prima di una trasfusione è comunque consigliabile che si alimenti con un pasto leggero;
- rilevare i parametri vitali basali: Pa, Fc e Tc.
- prima della venipuntura si procede alla preparazione e antisepsi della cute:
- l'antisettico di scelta è la clorexidina, preferibilmente in soluzione alcolica. Nelle persone non allergiche allo iodio sono utilizzabili anche gli anti iodofori;
- i dati relativi alla trasfusione (tipo di emocomponente, numero identificativo, data e ora di inizio e fine trasfusione, eventuali reazioni trasfusionali) devono essere riportati nella Cartella Trasfusionale. L'ora di fine trasfusione, con il suo esito, dovrà essere trasmesso alla Struttura Trasfusionale.

8) TRASFUSIONE

RESPONSABILITA': MEDICO/INFERMIERE

Per evitare che l'emocomponente sia trasfuso alla persona sbagliata o che sia trasfuso sangue incompatibile devono essere eseguiti i controlli previsti "prima di iniziare la terapia trasfusionale" e "prima dell'infusione dell'emocomponente" previsti dalla check list trasfusionale (Allegato 5).

Identificazione attiva del paziente e dell'unità:

prima di avviare la procedura di trasfusione **DUE OPERATORI (Medico e Infermiere)** devono:

Controllare l'INTEGRITÀ DELLA SACCA:

- ✓ lieve pressione sulla sacca per mettere in evidenza eventuali soluzioni di continuo
- ✓ i siti per la perforazione con il kit da infusione devono essere sigillati
- ✓ assenza di coaguli
- ✓ assenza di colorazioni anomale come sfumature brune o verdastre (contaminazione batterica) sfumature rubiniche (emolisi)

COMPATIBILITA' ABO NELLA TRASFUSIONE DI EMAZIE CONCENTRATE

GRUPPO DEL DONATORE

GRUPPO DEL RICEVENTE		0	A	B	AB
0		X			
A		X	X		
B		X		X	
AB		X	X	X	X

- verificare il GRUPPO SANGUIGNO del paziente (referto) e quello della sacca (etichetta di assegnazione) e confermare la compatibilità teorica come da tabella;
- registrare la verifica effettuata sulla corrispondente sezione della check list trasfusionale (Allegato 3a);

- inserire data, ora e firma (la firma deve essere leggibile oppure deve essere presente anche il timbro).

Al letto del paziente (Immediatamente prima della trasfusione)

DUE OPERATORI (Medico e Infermiere) devono:

- controllare la SCADENZA DELL'UNITÀ
- IDENTIFICARE correttamente il PAZIENTE chiedendo al paziente stesso di declinare le proprie generalità (nome, cognome, data di nascita), se le condizioni dello stesso lo consentono, verificando la loro corrispondenza con i dati riportati nella documentazione clinica e sulla sacca. In caso di paziente incosciente, si deve accertare l'identità in base ad un valido documento di riconoscimento o un parente o tutore
- CONTROLLARE **la corrispondenza dei dati del paziente con quanto riportato sull'etichetta della sacca e registrare nei campi corrispondenti della check list la verifica effettuata**
- CONTROLLARE che il GRUPPO SANGUIGNO del ricevente, riportato sui referti forniti dal Servizio Trasfusionale sia compatibile con quello riportato sull'etichetta di assegnazione e l'etichetta madre dell'emocomponente
- registrare la verifica effettuata sulla corrispondente sezione della Checklist; inserire data, ora e firma (la firma deve essere leggibile oppure deve essere presente anche il timbro).

La Checklist deve essere conservata insieme alla documentazione sanitaria (Allegati 3a e 3b)

Gestione della trasfusione

Subito prima della trasfusione devono essere rilevati e registrati nella documentazione sanitaria i parametri vitali del paziente.

La trasfusione deve essere avviata, immediatamente dopo aver collegato l'unità al set da trasfusione regolando la velocità di infusione a 15-20 gocce al minuto per i primi 15 minuti, poi secondo le indicazioni del Medico (in genere 60-80 gocce/min) a seconda delle condizioni cliniche ed emodinamiche del paziente.

In caso di trasfusione a domicilio il Medico deve essere presente per tutta la durata della trasfusione.

Il paziente deve essere sorvegliato per tutta la durata della trasfusione ed in particolare nei primi 15-20 minuti, tempo nel quale possono verificarsi reazioni trasfusionali importanti.

I tempi di trasfusione devono essere mediamente:

- ✓ Emazie Concentrate: 60'-90' per unità.

Per gli eritrociti concentrati, la trasfusione deve essere completata entro 4 ore al massimo dal momento di uscita dalle condizioni di conservazione standard.

Entro 60 minuti dalla conclusione della trasfusione ripetere il controllo e la registrazione nella documentazione sanitaria dei parametri vitali (PA, Fc, Tc).

Staccare dal retro dell'unità l'etichetta di assegnazione riportante le generalità del paziente, il suo gruppo sanguigno e i dati dell'emocomponente ed applicarla nella seconda pagina della checklist

(Allegati 3a e 3b)

Al termine della trasfusione il Medico, in collaborazione con l'infermiere, provvede a far pervenire alla ST il MODULO DI TRASFUSIONE/TRACCIABILITÀ nel più breve tempo possibile, per la registrazione dell'avvenuta trasfusione.

Il materiale utilizzato per la trasfusione presso il domicilio viene smaltito utilizzando il contenitore fornito dal servizio domiciliare ed allontanato nel più breve tempo possibile.

N.B.: Tutte le registrazioni nella documentazione sanitaria, sia informatica che cartacea, relative all'emocomponente da trasfondere, devono riportare il codice identificativo completo dell'unità, costituito da 13 caratteri (es: I103019008765), riportato sull'etichetta di validazione dell'emocomponente e sul relativo modulo di tracciabilità emocomponente, che identifica in maniera univoca l'unità e garantisce la tracciabilità della trasfusione.

Unità non trasfuse

- In caso di mancata trasfusione dell'emocomponente, per sopravvenute problematiche cliniche del paziente, il Medico Responsabile Terapeutico lo comunica tempestivamente per telefono alla ST e fa in modo che l'unità venga restituita alla ST, con allegato il MODULO DI TRASFUSIONE/TRACCIABILITÀ/RESTITUZIONE compilato e firmato nella parte in cui si attesta la corretta conservazione dell'unità
- In caso di mancata trasfusione dell'emocomponente per danneggiamento, cattiva conservazione o smarrimento dell'unità, il Medico Responsabile Terapeutico lo comunica tempestivamente per telefono alla ST e successivamente fornisce comunicazione scritta e motivata, tramite la compilazione del MODULO DI TRASFUSIONE/TRACCIABILITÀ.
- In tutti i casi l'unità deve essere restituita al ST nel più breve tempo possibile, previa attivazione del servizio SVS

7. SORVEGLIANZA

RESPONSABILITA': MEDICO / INFERMIERE

Ogni paziente trasfuso è potenzialmente soggetto a complicanze specifiche della terapia trasfusionale. Le reazioni trasfusionali più frequenti sono:

- reazioni immediate dovute a un meccanismo immunologico come: febbrile non emolitica, allergica, emolitica;
- reazione settica da contaminazione batterica;
- sovraccarico circolatorio;
- intossicazione da citrato e potassio.

È importante che l'infermiere e il medico sorveglino frequentemente il paziente durante l'infusione di sangue ed emocomponenti per cogliere tempestivamente i segni d'insorgenza delle reazioni trasfusionali.
In caso di reazione trasfusionale (anche sospetta):
l'Infermiere e/o il Responsabile Terapeutico devono:

- interrompere immediatamente la trasfusione
- mantenere pervio l'accesso venoso con soluzione fisiologica
- controllare e registrare i parametri vitali
- controllare al letto del paziente i dati presenti sulla unità trasfusa e confrontarli con i dati identificativi del paziente presenti nella documentazione clinica e sul braccialetto identificativo
- valutare le condizioni cliniche del paziente,
- eseguire manovre di primo soccorso e attivare112
- effettuare eventuale terapia - prendere contatto con il Medico della ST
- registrare in documentazione sanitaria l'avvenuta reazione
- compilare la parte riservata alle reazioni trasfusionali del MODULO DI TRASFUSIONE/TRACCIABILITÀ/REAZIONI AVVERSE dell'unità
- prelevare un campione ematico post-trasfusione (provetta EDTA 7ml), con le stesse modalità indicate per il campione destinato alle prove di compatibilità pretrasfusionale.

Inviare alla ST:
- il MODULO DI TRASFUSIONE/TRACCIABILITÀ/REAZIONI AVVERSE, in cui il Medico ha descritto la tipologia della reazione trasfusionale
- l'unità residua unitamente al set di infusione ed eventuali altre unità non trasfuse
- Il campione ematico post trasfusione

Bisogna, poi:
- controllare la quantità ed il colore delle urine del paziente dall'inizio della reazione fino alle 24 ore successive
- 5-7 ore dopo la reazione controllare i seguenti parametri: emocromo, bilirubina totale, diretta ed indiretta, aptoglobina, azotemia, creatinina, esame urine, dosaggio IgA
- in caso di ipertermia effettuare una emocoltura

La segnalazione di eventuali reazioni trasfusionali deve essere effettuata del medico RT compilando il modulo "Notifica reazione avversa associata alla trasfusione di sangue/emocomponenti" (Allegato 4a, 4b)

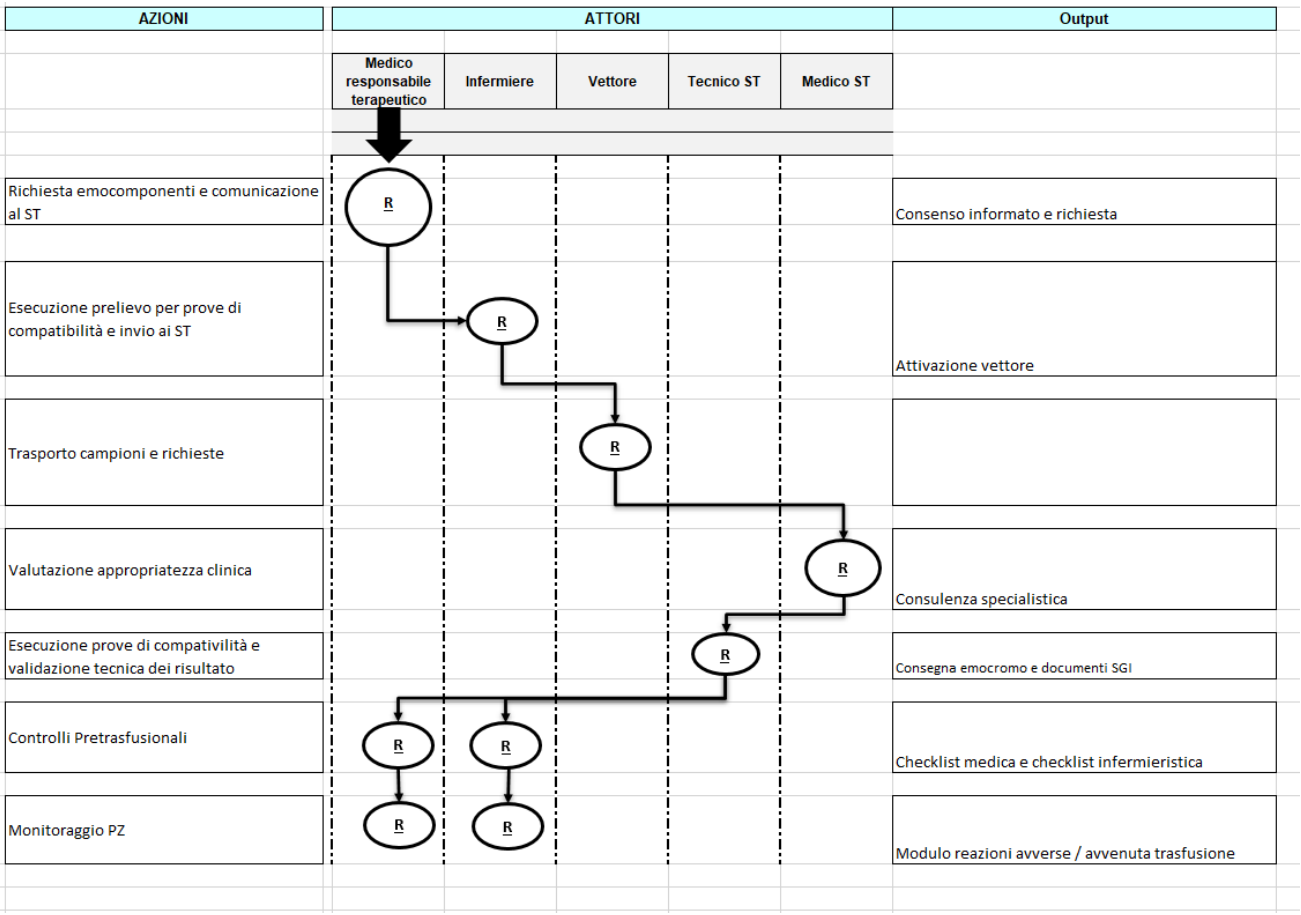
8. MONITORAGGIO

Indicatori di processo:

- *numero di consensi/numero di cartelle cliniche = 100%*

Responsabile monitoraggio è il Responsabile UF

9.SWIM LANE


AZIONI
ATTORI
Output
Medico responsabile terapeutico
Infermiere
Vettore
Tecnico ST
Medico ST
Richiesta emocomponenti e comunicazione al ST
Consenso informato e richiesta
Esecuzione prelievo per prove di compatibilità e invio ai ST
Attivazione vettore
Trasporto campioni e richieste
Valutazione appropriatezza clinica
Consulenza specialistica
Esecuzione prove di compativilità e validazione tecnica dei risultato
Consegna emocromo e documenti SGI
Controlli Pretrasfusionali
Checklist medica e checklist infermieristica
Monitoraggio PZ
Modulo reazioni avverse / avvenuta trasfusione
R

Scheda FMECA

Struttura: Processo: Trasfusione domiciliare di emazie concentrate						DETERMINAZIONE INDICE PRIORITÀ DI RISCHIO			
FASI / ATTIVITÀ	CRITICITÀ		RACCOMANDAZIONI			Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Tot. IPR
	Fallimenti attivi	Fallimenti latenti	Persone	Tecnologia	Organizzazione				
Richiesta emocomponenti(consenso e compilazione richiesta)	Mancanza consenso		formazione			9	2	1	18
	Incompletezza della richiesta		formazione			3	5	1	15
	Mancanza firme richiesta		formazione			9	2	1	18
Esecuzione prelievi per prove di compatibilità	Errata tecnica di prelievo o preparazione del campione o inoculo-geità del materiale		formazione		Mantenimento competenze	8	2	1	16
	Mancata identificazione attiva del Paziente		Formazione		Presenza di un secondo operatore	10	1	1	10

Struttura: Processo: Trasfusione domiciliare di emazie concentrate						DETERMINAZIONE INDICE PRIORITÀ DI RISCHIO			
FASI / ATTIVITÀ	CRITICITÀ		RACCOMANDAZIONI			Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Tot. IPR
	Fallimenti attivi	Fallimenti latenti	Persone	Tecnologia	Organizzazione				
Trasporto emocomponenti/richieste /campioni		Trasporto a temperatura non idonea			Verifica randomdella posizionedei vei-colo/temperatura all'interno dello stesso	9	1	1	9
Valutazione appropriatez-za clinica richiesta									
Esecuzione prove di com-patibilità e validazione tecnica dei risultati e con-segna degli emocompo-nenti	Errore esecuzio-ne del test			Fallimento della tecnolo-gia / mitigato da autointr-pretazione		10	1	1	10
	Errore di interpreta-zione del test		Formazione di Tecnici e Medici	Mitigato da autointerpreta-zione		10	1	1	10
	Errore della con-segna dell'emo-compo-		Formazione di Tecnici e Medici	Gesionale: Incrocio bar code richiesta con bar code sacca		10	1	1	10

Struttura: Processo: Trasfusione domiciliare di emazie concentrate						DETERMINAZIONE INDICE PRIORITÀ DI RISCHIO			
FASI / ATTIVITÀ	CRITICITÀ		RACCOMANDAZIONI			Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Tot IPR
	Fallimenti attivi	Fallimenti latenti	Persone	Tecnologia	Organizzazione				
	nente								
Controlli identità pretrasfusionalil / Check List sicurezza emotrasfusionale		Mancato rispetto check-list	Formazione		Presenza secondo operatore	10	1	1	10
Monitoraggio paziente durante trasfusione		Mancata aderenza al protocollo			Assicurare presenza del personale medico per tutta la durata della trasfusione	10	1	1	10

ELENCO ALLEGATI

- ✓ ALLEGATO 1 - Consenso informato alla trasfusione
- ✓ ALLEGATO 2 - Modulo di richiesta di sangue ed emocomponenti per trasfusione domiciliare
- ✓ ALLEGATO 3 - Check list trasfusionale
- ✓ ALLEGATO 4 Notifica reazione avversa associata alla trasfusione di sangue/emocomponenti
- ✓ ALLEGATO 5 - Modulo attivazione trasporti emocomponenti
- ✓ ALLEGATO 6 Check List Zaino Emergenza

Allegato 1: modulo consenso informato

CONSENSO INFORMATO
AL TRATTAMENTO CON EMODERIVATI

Io sottoscritto/a ..... nato/a il ..... .a.....
sono stato informato dal Dott. ..... che per le mie condizioni cliniche potrei essere sottoposto ad un trattamento terapeutico con sangue omologo/emocomponenti*, che tale pratica non è completamente esente da rischi (inclusa la trasmissione di virus dell'immunodeficienza, dell'epatite, ecc.).
Dichiaro di aver ben compreso quanto mi è stato spiegato dal Dott..... in ordine alle mie condizioni cliniche, ai rischi connessi alla terapia trasfusionale ed a quelli che potrebbero derivare dal non sottopormi al trattamento. Sono informato, inoltre, che posso revocare in qualsiasi momento il consenso.
Quindi :

☐ **ACCONSENTO**

ad essere sottoposto alla somministrazione di emotrasfusioni e/o emoderivati che si rendono necessari per tutta la durata della terapia. Data .....

Firma del paziente/genitore/tutore/amministratore.....
Firma del medico che acquisisce il consenso.....

☐ **NON ACCONSENTO**

ad essere sottoposto alla somministrazione di emotrasfusioni e/o emoderivati che si rendono necessari per tutta la durata della terapia. Data .....

Firma del paziente/genitore/tutore/amministratore.....
Firma del medico che acquisisce il consenso.....

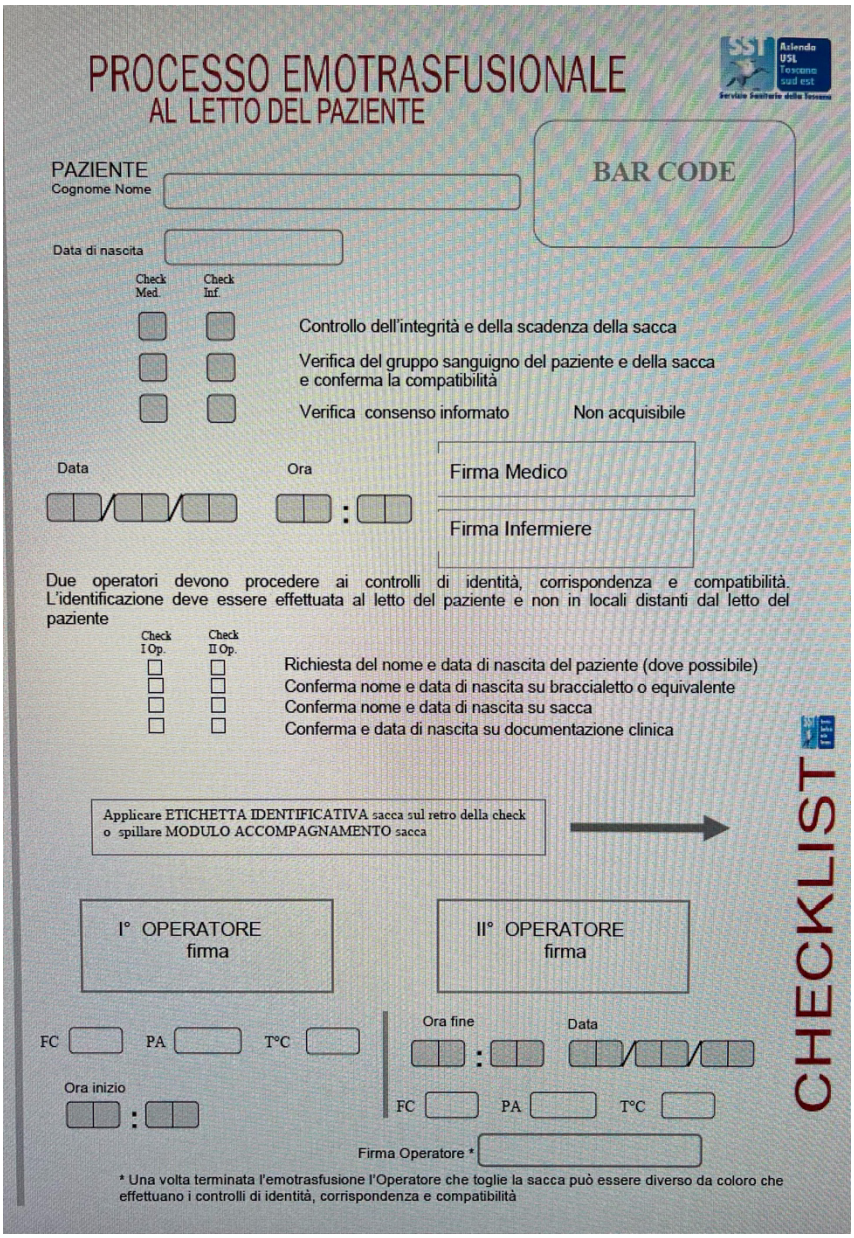
☐ **REVOCO IL CONSENSO**

ad essere sottoposto alla somministrazione di emotrasfusioni e/o emoderivati che si rendono necessari per tutta la durata della terapia. Data .....

Firma del paziente/genitore/tutore/amministratore.....
Firma del medico che acquisisce il consenso.....

(*) *cancellare la voce che non interessa*

Allegato 2: Modulo richiesta sangue ed emocomponenti (*fare riferimento al modulo adottato dalla Struttura Trasfusionale di riferimento)*



PROCESSO EMOTRASFUSIONALE
AL LETTO DEL PAZIENTE

PAZIENTE
Cognome Nome

BAR CODE

Data di nascita

Check Med. | Check Inf.

Controllo dell'integrità e della scadenza della sacca

Verifica del gruppo sanguigno del paziente e della sacca e conferma la compatibilità

Verifica consenso informato Non acquisibile

Data Ora

Firma Medico

Firma Infermiere

Due operatori devono procedere ai controlli di identità, corrispondenza e compatibilità. L'identificazione deve essere effettuata al letto del paziente e non in locali distanti dal letto del paziente

Check I Op. | Check II Op.

Richiesta del nome e data di nascita del paziente (dove possibile)
Conferma nome e data di nascita su braccialetto o equivalente
Conferma nome e data di nascita su sacca
Conferma e data di nascita su documentazione clinica

Applicare ETICHETTA IDENTIFICATIVA sacca sul retro della check o spillare MODULO ACCOMPAGNAMENTO sacca

I° OPERATORE firma

II° OPERATORE firma

FC PA T°C

Ora inizio

Ora fine Data

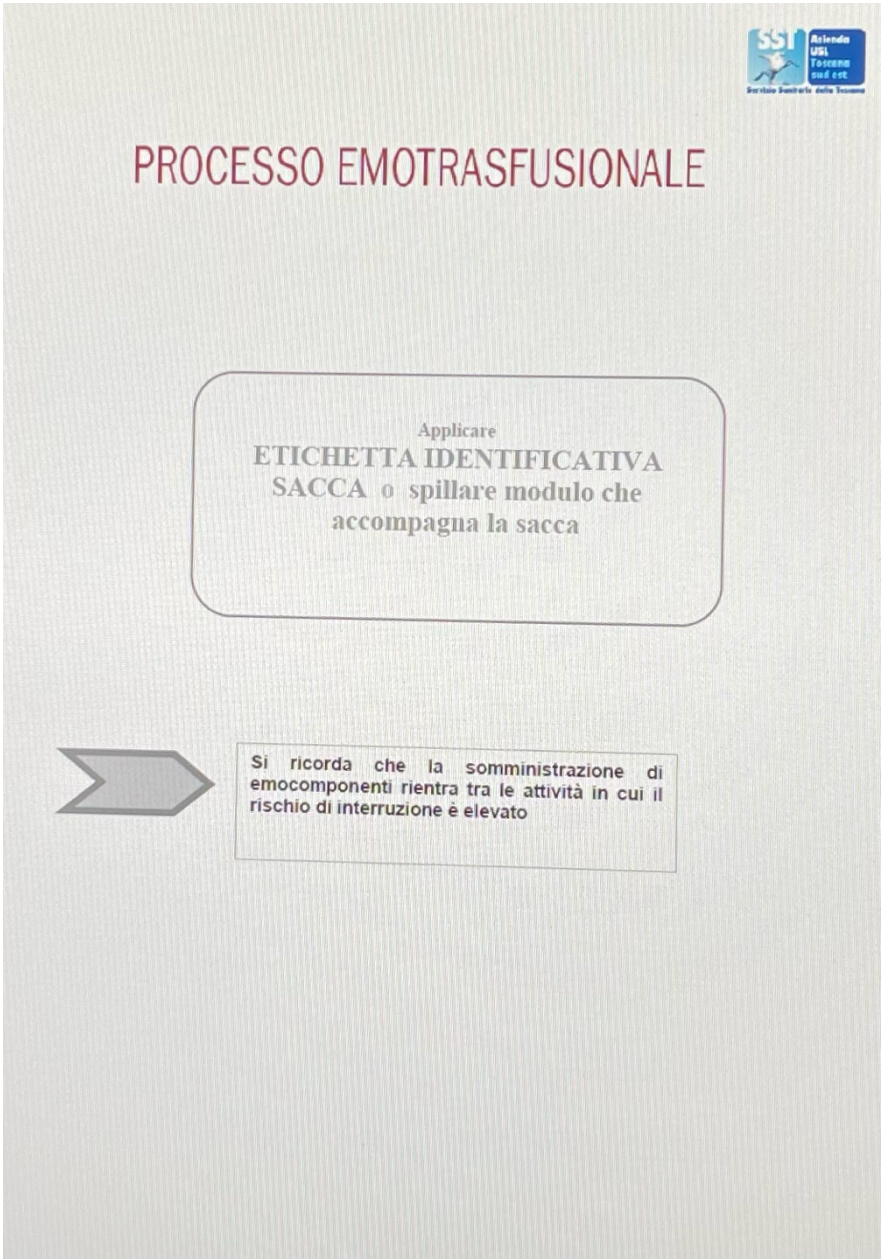
FC PA T°C

Firma Operatore *

* Una volta terminata l'emotrasfusione l'Operatore che toglie la sacca può essere diverso da coloro che effettuano i controlli di identità, corrispondenza e compatibilità

CHECKLIST

Allegato 3: Chest list trasfusionale



Allegato 4: Notifica di reazione avversa (*fare riferimento al modulo adottato dalla Struttura Trasfusionale di riferimento)*

Allegato 5: Attivazione trasporti

ATTIVAZIONE TRASPORTI SANGUE
VETTORE ATI CROCE ITALIA MARCHE – SVS GESTIONE SERVIZI
(fax 0586 838808 Tel. 0586 88.88.88 – 800 073 330)

IDENTIFICAZIONE STRUTTURA RICHIEDENTE

ASL / AOU _____

Ospedale _____ Reparto _____

Telefono reparto_____ Fax_____

Operatore Sanitario di riferimento_____

Data_____ Ora invio richiesta_____

Luogo prelievo presso la struttura richiedente (SI) (NO)

Se NO il vettore dovrà recarsi per il ritiro del prodotto/campione presso la struttura e recapitare alla struttura richiedente

ASL / AOU _____

Ospedale _____ Reparto _____

Telefono reparto_____ Fax_____

Operatore Sanitario di riferimento_____

	TIPO DI TRASPORTO	Tipologia di campioni da trasportare e luogo destinazione (escluso in caso di risposta NO)	URGENTE	NON URGENTE	TRASPORTO RICHIESTO PER (Indicare nella parte sottostante la data e l'ora per il ritiro)
	CHIMICO CLINICA				Data_____ Ore_____
	EMATOLOGIA COAGULAZIONE				Data_____ Ore_____
	MICROBIOLOGIA VIROLOGIA				Data_____ Ore_____
	BIOLOGIA MOLECOLARE				Data_____ Ore_____
	TOSSICOLOGIA				Data_____ Ore_____
	EMOCOMPONENTI (sangue, piastrine e plasma per uso clinico)				Data_____ Ore_____

Allegato 6: Check list

CHECK LIST ZAINO EMERGENZA

- ✓ n. 2 aghi cannula (18-20)
- ✓ n. 1 unità di soluzione fisiologica da 500 ml n.
- ✓ 2 unità di soluzione fisiologica da 100 ml
- ✓ n. 2 fiale di soluzione fisiologica da 10 ml
- ✓ n. 2 siringhe da 10 ml
- ✓ n. 2 siringhe da 20 ml
- ✓ n. 1 scatola di Adrenalina da 1 mg fiale (da conservare in frigorifero)
- ✓ una confezione: Urbason 20 mg, Solu-Medrol 40 mg,
- ✓ Solu-Medrol 125 mg;
- ✓ n. 2 fl. Flebocortid 1 gr. (Solucortef 1gr);
- ✓ n. 1 confezione di Furosemide fiale 20 mg
- ✓ n. 1 confezione *Diazepam* fiale 10 mg
- ✓ n.1 confezione di *Trimeton* fiale 10 mg
- ✓ n.1 confezione di *Broncovaleas*
- ✓ n. 1 flacone di Paracetamolo 1000 ml
- ✓ ATB ad ampio spettro